DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: RODRIGO MOLINA JARAMILLO **Identificación** CC 2685549
Edad: 79 AÑOS **Empresa:** EMSSANAR S.A.S SUBSIDIADO-2025-2
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 03/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	441302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA	AMI	

Cirujano: JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES257 JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad** GASTROENTEROLOGIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: C168 LESION DE SITIOS CONTIGUOS DEL ESTOMAGO

Dx Postoperatorio: K294 GASTRITIS CRONICA ATROFICA

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 03/11/26 **Fecha Final** 03/11/26
Hora Inicio 14:10:00 **Hora Final** 14:22:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO CON SEDACIÓN BAJO ANESTESIOLOGIA GENERAL DRA ELBIA RODRIGUEZ(FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL)***
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE).
PROCEDIMIENTO REALIZADO CON EQUIPO OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II
REALIZADO POR JOHANN ALVAREZ.
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: Sindrome constitucional
ESOFAGO: Normal hasta tercio distal. Hiato amplio HILLS 2.
ESTOMAGO: Explorado hasta píloro incluyendo retrovisión para pequeña curva y fondo gástrico normales. Mucosa corporal adelgazada con visualización de vasos. Hacia unión corporoantral sobre curvatura mayor, pared anterior y curvatura menor se observó gran úlcera excavada, de bordes elevados con angiectasias sin sangrado. Se realiza nueva biopsia por no evidenciarse histología en historia clínica. Motilidad antral normal. Píloro franqueable.
DUODENO: Normal hasta segunda porción.
BIOPSIAS: FRASCO 1: Lesión de cuerpo gástrico.
***CONCLUSION:
1. ÚLCERA GIGANTE DE CUERPO GÁSTRICO: NEO SEGÚN HC
2. GASTRITIS CORPOROANTRAL ATRÓFICA SEVERA

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Tejidos enviados a patología : **SI** ☒ **NO** ☐
FRASCO 1: LESIÓN DE CUERPO GÁSTRICO.



JOHANN MARIO ALVAREZ GIL
Reg. 1130587580
GASTROENTEROLOGIA

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***